



GUIA PARA PACIENTES

Gota e ácido úrico: o que fazer na crise e como evitar a próxima

o que a ciência sabe, inclusive sobre a alimentação

A crise de gota dói muito, mas tem explicação e tem tratamento. Entenda o que fazer nas primeiras horas, quando é urgência e por que é o tratamento de longo prazo que evita a próxima crise.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **GOTA**

Para quem é:

Para quem já teve gota **confirmada por um médico** e está com uma crise parecida com as anteriores, ou para quem ouviu que tem "ácido úrico alto" e quer entender o assunto, **sem nenhum sinal de alerta da próxima página.**

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem está na **primeira crise**, sem diagnóstico: primeiro, avaliação médica.
- Quem tem doença nos rins, transplante ou usa muitos remédios: as medidas valem, mas a conversa com o médico vem antes.
- Quem já usa remédio para gota: não pare nem troque nada por causa deste guia.

O que você vai precisar:

- Gelo ou bolsa de gelo e um pano fino.
- Um travesseiro para apoiar a perna.
- Chinelo aberto ou calçado folgado.
- Seus últimos exames de ácido úrico, se tiver.
- Uma caneta para o rastreador da Página 9.

Regra de ouro:

Na crise: articulação **em repouso** e gelo **sempre com pano**. Remédio, só o que **o seu médico** indicar.

Febre com articulação vermelha e quente: **leia a Página 3 agora.**

A crise de gota é muito dolorosa, mas, em geral, não é perigosa. O problema é que outras doenças imitam a gota, e uma delas é urgência. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure um pronto-socorro HOJE se:

- **Febre ou calafrios** junto com uma articulação **vermelha, quente e inchada**. Pode ser **infecção dentro da articulação** (artrite séptica). É emergência médica: pode danificar a articulação e ter complicações graves [5]. Quem já tem gota também pode ter infecção (opinião clínica).
- Você se sente **muito mal**: prostrado, confuso ou com tontura forte (opinião clínica).
- A dor está **insuportável**, não cede com nada, ou você **não consegue apoiar o pé** de jeito nenhum (opinião clínica).

Procure avaliação médica em 24 a 48 horas (prazo de bom senso clínico) se:

- É a **primeira crise** e não há diagnóstico. A forma mais segura de confirmar a gota é retirar um pouco de líquido da articulação com agulha e procurar os cristais no microscópio [4]. A mesma punção ajuda a afastar infecção [5].
- A crise pegou **várias articulações** ao mesmo tempo.
- A crise está **diferente** das anteriores ou **não melhora** em poucos dias.

Uma observação honesta: só olhando, nem o médico consegue sempre diferenciar gota de infecção. Na dúvida, a punção decide [5].

Cristais dentro da articulação

O ácido úrico é uma substância que todos temos no sangue. Quando fica alto por muito tempo, pode formar **cristais** que se depositam nas articulações e ao redor delas. A gota é a inflamação causada por esses cristais [3].

Ácido úrico alto não é o mesmo que gota

Ácido úrico alto é o principal fator de risco [3], mas muita gente tem o exame alterado e **nunca tem crise**. Sem crise, a diretriz americana **não recomenda**, como regra, remédio para baixar o ácido úrico [1].

Como é a crise típica

- Dor forte que se instala em **poucas horas**, muitas vezes à noite ou de madrugada (opinião clínica).
- Articulação **vermelha, quente e inchada**, a ponto de doer com o lençol encostando (opinião clínica).
- Local clássico: a **base do dedão do pé**. Também é comum no **tornozelo** e no **peito do pé** [4]. O **joelho** também pode ser atingido (opinião clínica).

A crise passa. A gota, não.

A gota aparece em crises, mas é uma **doença crônica** [3]. Sem tratamento, os cristais continuam lá entre uma crise e outra (opinião clínica).

Um detalhe que confunde: durante a crise, o exame de ácido úrico pode vir **normal**. Isso não afasta gota (opinião clínica).

O que você faz em casa **ajuda**, mas **não substitui** a avaliação e o remédio indicado pelo médico. **Ligue ou procure seu médico logo no início da crise.**

Medida 1 — Repouso da articulação

Como fazer: poupe a articulação doente: menos tempo de pé, sem caminhada longa, sem exercício até a crise ceder. Use chinelo aberto ou calçado folgado.

Sensação correta: a dor não aumenta enquanto você está parado.

Erro comum: "andar para soltar" ou forçar o pé num sapato apertado.

Medida 2 — Gelo

A diretriz americana recomenda gelo como **complemento** ao remédio [1]. Num estudo pequeno, com 19 pessoas, quem usou gelo junto com o tratamento teve mais alívio da dor [6].

Como fazer: gelo envolto em pano fino, de 15 a 20 minutos, algumas vezes ao dia.

Sensação correta: frio intenso que alivia, sem queimar.

Erro comum: gelo direto na pele, ou dormir com a bolsa encostada: risco de queimadura pelo frio.

Medida 3 — Perna apoiada

Como fazer: sentado ou deitado, apoie a perna num travesseiro, um pouco acima do nível do quadril.

Sensação correta: menos latejamento.

Erro comum: passar dias inteiros deitado sem se mexer.

Tempo de gelo e perna elevada: orientação prática, não testada em estudo.

Este guia não indica remédio nem dose. Quem escolhe é o seu médico, porque depende dos seus rins, estômago, coração, pressão, glicose e dos remédios que você já usa.

1. Remédio para apagar a crise

Existem várias opções eficazes, e a escolha é individual [1][2].

2. Tratamento para baixar o ácido úrico

É **este** que evita a próxima crise. Com o ácido úrico baixo por tempo suficiente, os cristais se dissolvem, e as crises e os tofos diminuem [3].

- **Meta:** ácido úrico **abaixo de 6 mg/dL**; em gota grave, a diretriz europeia sugere abaixo de 5 [1][2]. O exame é repetido e o tratamento é ajustado até chegar lá. É o "tratar até o alvo".
- **Funciona:** num estudo com 517 pessoas, educação mais "tratar até o alvo" levou 95% à meta, contra 30% no cuidado habitual [18].
- **Quem precisa:** quem tem tofo, dano no raio-X ou 2 ou mais crises por ano [1]. Depois da primeira crise, a decisão é individual [1][2].
- **No começo, as crises podem voltar.** Não é falha. Por isso o médico costuma associar uma proteção contra crises por 3 a 6 meses [1].
- **É de longo prazo.** A diretriz americana sugere continuar indefinidamente, em vez de parar [1].

A verdade que pouca gente conta

Num estudo com mais de 16 mil pessoas, o padrão de alimentação explicou **menos de 1%** da variação do ácido úrico; a genética, cerca de 24% [10]. A diretriz americana resume: a dieta muda pouco o ácido úrico, mas **pode desencadear crises** [1].

Vale a pena limitar

- **Álcool, principalmente cerveja.** Em 47 mil homens, cada dose diária de cerveja aumentou o risco de gota em cerca de 50%; destilados, menos [8]. Vinho moderado não aumentou o risco [8], mas isso não é convite a beber.
- **Refrigerante e bebidas com açúcar ou ricas em frutose.** Dois ou mais por dia: risco cerca de 85% maior. Refrigerante diet não se associou [9].
- **Excesso de carnes, como a vermelha, e de frutos do mar** [2][7].

Pode ajudar

- **Laticínios, principalmente os magros,** se associaram a menor risco [7], e a diretriz europeia os incentiva [2].
- **Perder peso,** se houver excesso: a evidência é favorável, mas de qualidade baixa a moderada [11].

Mitos e incertezas

- **Feijão, ervilha, espinafre e cogumelo** são ricos em purina, mas **não** aumentaram o risco de gota [7].
- **Cereja:** associada a menos crises num estudo observacional [12]. Não prova efeito.
- **Suplemento de vitamina C:** a diretriz americana recomenda **contra** [1].

Estudos de alimentação, em sua maioria, são observacionais: mostram associação, não causa.

Uma doença que raramente vem sozinha

Num levantamento nos Estados Unidos, entre pessoas com gota, 74% tinham pressão alta, 71% algum grau de doença nos rins, 53% obesidade e 26% diabetes. Cerca de 14% já tinham tido infarto [15].

Coração

Num estudo com mais de 51 mil homens, acompanhados por 12 anos, quem tinha gota morreu mais, inclusive por doença do coração [13].

Rins

A gota se associa a mais doença renal crônica e a mais cálculo renal [14].

O ponto honesto

- Esses estudos mostram **associação**. Não provam que a gota seja a causa.
- **Ainda não está provado** que baixar o ácido úrico, por si só, proteja o coração ou os rins. Em dois grandes estudos com pessoas **sem gota**, o remédio que baixa o ácido úrico não reduziu infarto, AVC nem morte cardiovascular [16] e não freou a perda de função dos rins [17].
- Por isso a diretriz europeia recomenda **investigar e cuidar** de pressão, glicose, colesterol, peso, rins e cigarro em toda pessoa com gota [2].

Na consulta de gota, cuidar do pé é só uma parte do trabalho.

Plano

Fase	O que fazer
Primeiras horas da crise	Repouso, gelo com pano, perna apoiada. Contato com o médico. Revisar a Página 3.
Dias 2 a 7	Seguir o que foi prescrito. Voltar a andar conforme a dor cede.
Até 4 semanas	Consulta: confirmar o diagnóstico, avaliar rins e outros exames, discutir o tratamento para baixar o ácido úrico.
Meses seguintes	Repetir o ácido úrico até a meta. Rever álcool, bebidas com açúcar e peso.
Longo prazo	Manter o tratamento e os exames periódicos. Não parar por conta própria.

Fases e prazos: orientação prática (opinião clínica), não protocolo testado.

Rastreador

Data	Articulação	Dor (0–10)	Febre? (S/N)	Provável gatilho	Ácido úrico (mg/dL)	Tomando o tratamento? (S/N)

0 = sem dor · 10 = a pior dor que você imagina. Anote cada crise e cada exame.

Leve esta tabela para a consulta. Ela mostra ao médico quantas crises houve, onde, e se a meta está sendo atingida.

1. Achar que é só cortar a carne.

A alimentação ajuda, mas, sozinha, raramente controla a gota [1][10]. Quem tem crises repetidas costuma precisar de tratamento para baixar o ácido úrico [1].

2. Parar o tratamento quando a crise passa.

Numa revisão de estudos, menos da metade das pessoas com gota seguia o tratamento como prescrito [19]. O tratamento que evita crises é de longo prazo [1][3]. Dúvida ou efeito colateral: fale com seu médico.

3. Desistir porque teve crise no início do tratamento.

Crises nos primeiros meses podem acontecer e não significam que o tratamento falhou [1].

4. Tratar o exame, e não a pessoa.

Ácido úrico alto, sem crise, não é gota, e nem sempre precisa de remédio [1]. A decisão é na consulta.

5. Se automedicar na crise.

Remédio para dor e inflamação também tem risco, principalmente para rins, estômago e pressão (opinião clínica). Remédio de outra pessoa, nunca.

Bônus: achar que "é só mais uma crise" quando vem com febre.

Febre com articulação quente pode ser infecção. **Volte à Página 3** [5].

Procure avaliação se:

- Você teve a **primeira crise** e ainda não tem diagnóstico confirmado [4].
- Você teve **2 ou mais crises** no último ano [1].
- Surgiram **caroços endurecidos** sob a pele, perto das articulações. Podem ser **tofoss** [1] (opinião clínica quanto à suspeita).
- Você tem **cálculo renal** ou **doença nos rins**.
- Você já trata e o ácido úrico **não está abaixo da meta** [1].
- Você quer **parar ou trocar** o tratamento por causa de efeito colateral.
- **A qualquer momento:** apareceu algum sinal da Página 3.

Se quiser uma avaliação

A consulta começa por **história e exame físico** das articulações. Conforme o caso, pedem-se punção para pesquisar cristais, exames de sangue (ácido úrico, função dos rins, glicose e colesterol) e imagem (opinião clínica). A decisão sobre tratamento é tomada junto com você. Quando o caso pede reumatologista, clínico ou cardiologista, o encaminhamento faz parte do cuidado.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. FitzGerald JD, Dalbeth N, Mikuls T, Brignardello-Petersen R, et al. **2020 American College of Rheumatology Guideline for the Management of Gout.** Arthritis Care Res (Hoboken). 2020;72(6):744-760. doi:10.1002/acr.24180. PMID: 32391934. (Publicada também em Arthritis Rheumatol. 2020;72(6):879-895. doi:10.1002/art.41247. PMID: 32390306.)
2. Richette P, Doherty M, Pascual E, Barskova V, et al. **2016 updated EULAR evidence-based recommendations for the management of gout.** Ann Rheum Dis. 2017;76(1):29-42. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209707. PMID: 27457514.
3. Dalbeth N, Gosling AL, Gaffo A, Abhishek A. **Gout.** Lancet. 2021;397(10287):1843-1855. doi:10.1016/S0140-6736(21)00569-9. PMID: 33798500.
4. Neogi T, Jansen TL, Dalbeth N, Fransen J, et al. **2015 Gout classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative.** Ann Rheum Dis. 2015;74(10):1789-1798. doi:10.1136/annrheumdis-2015-208237. PMID: 26359487.
5. Mathews CJ, Weston VC, Jones A, Field M, et al. **Bacterial septic arthritis in adults.** Lancet. 2010;375(9717):846-855. doi:10.1016/S0140-6736(09)61595-6. PMID: 20206778.
6. Schlesinger N, Detry MA, Holland BK, Baker DG, et al. **Local ice therapy during bouts of acute gouty arthritis.** J Rheumatol. 2002;29(2):331-334. PMID: 11838852.
7. Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan G. **Purine-rich foods, dairy and protein intake, and the risk of gout in men.** N Engl J Med. 2004;350(11):1093-1103. doi:10.1056/NEJMoa035700. PMID: 15014182.
8. Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Willett W, Curhan G. **Alcohol intake and risk of incident gout in men: a prospective study.** Lancet. 2004;363(9417):1277-1281. doi:10.1016/S0140-6736(04)16000-5. PMID: 15094272.
9. Choi HK, Curhan G. **Soft drinks, fructose consumption, and the risk of gout in men: prospective cohort study.** BMJ. 2008;336(7639):309-312. doi:10.1136/bmj.39449.819271.BE. PMID: 18244959.
10. Major TJ, Topless RK, Dalbeth N, Merriman TR. **Evaluation of the diet wide contribution to serum urate levels: meta-analysis of population based cohorts.** BMJ. 2018;363:k3951. doi:10.1136/bmj.k3951. PMID: 30305269.
11. Nielsen SM, Bartels EM, Henriksen M, Wæhrens EE, et al. **Weight loss for overweight and obese individuals with gout: a systematic review of longitudinal studies.** Ann Rheum Dis. 2017;76(11):1870-1882. doi:10.1136/annrheumdis-2017-211472. PMID: 28866649.
12. Zhang Y, Neogi T, Chen C, Chaisson C, et al. **Cherry consumption and decreased risk of recurrent gout attacks.** Arthritis Rheum. 2012;64(12):4004-4011. doi:10.1002/art.34677. PMID: 23023818.
13. Choi HK, Curhan G. **Independent impact of gout on mortality and risk for coronary heart disease.** Circulation. 2007;116(8):894-900. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.703389. PMID: 17698728.
14. Roughley MJ, Belcher J, Mallen CD, Roddy E. **Gout and risk of chronic kidney disease and nephrolithiasis: meta-analysis of observational studies.** Arthritis Res Ther. 2015;17:90. doi:10.1186/s13075-015-0610-9. PMID: 25889144.
15. Zhu Y, Pandya BJ, Choi HK. **Comorbidities of gout and hyperuricemia in the US general population: NHANES 2007-2008.** Am J Med. 2012;125(7):679-687.e1. doi:10.1016/j.amjmed.2011.09.033. PMID: 22626509.
16. Mackenzie IS, Hawkey CJ, Ford I, Greenlaw N, et al; ALL-HEART Study Group. **Allopurinol versus usual care in UK patients with ischaemic heart disease (ALL-HEART): a multicentre, prospective, randomised, open-label, blinded-endpoint trial.** Lancet. 2022;400(10359):1195-1205. doi:10.1016/S0140-6736(22)01657-9. PMID: 36216006.
17. Badve SV, Pascoe EM, Tikku A, Boudville N, et al; CKD-FIX Study Investigators. **Effects of allopurinol on the progression of chronic kidney disease.** N Engl J Med. 2020;382(26):2504-2513. doi:10.1056/NEJMoa1915833. PMID: 32579811.
18. Doherty M, Jenkins W, Richardson H, Sarmanova A, et al. **Efficacy and cost-effectiveness of nurse-led care involving education and engagement of patients and a treat-to-target urate-lowering strategy versus usual care for gout: a randomised controlled trial.** Lancet. 2018;392(10156):1403-1412. doi:10.1016/S0140-6736(18)32158-5. PMID: 30343856.
19. Scheepers LEJM, van Onna M, Stehouwer CDA, Singh JA, et al. **Medication adherence among patients with gout: a systematic review and meta-analysis.** Semin Arthritis Rheum. 2018;47(5):689-702. doi:10.1016/j.semarthrit.2017.09.007. PMID: 29198878.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765